二、病因

1.抗反流屏障——以 **LES** 结构和/或功能障碍、尤其功能障碍最重要

食管裂孔疝、贲门失弛缓症**术后** VS 贲门失弛缓症是LES痉挛,不会反流

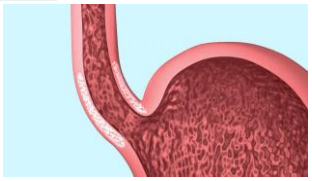
胃内压增高（胃排空延迟、胃扩张等）、腹内压增高（便秘、肥胖、妊娠、腹水等）

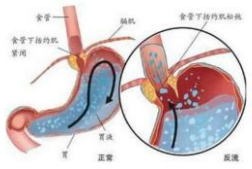
高脂食物、巧克力 排空↓→胃内压↑　排空速度:糖>蛋白质>脂肪

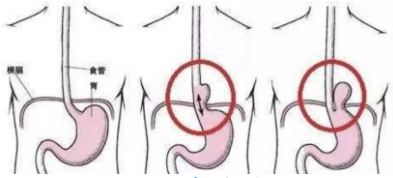
胰高血糖素、促胰液素、缩胆囊素 CCK、前列腺素、血管活性肠肽 VIP 下位抑制上位→抑制胃排空→胃内压↑

钙拮抗剂 CCB、地西泮、硝酸甘油、抗胆碱药等

（记少不记多：**胃泌素、胃动素、ACh、治疗 GERD 药物不会导致 LES 压力降低**）

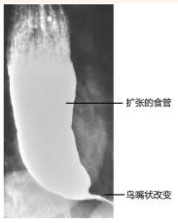


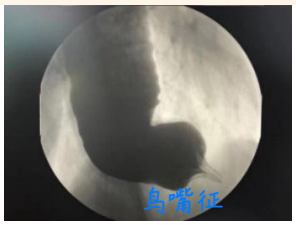




食管裂孔疝:一部分胃经过食管裂孔从腹腔进入胸腔

《外科学》：食管贲门失弛缓症是食管下 2/3 部的肌间神经丛受损→食管下括约肌不能松弛→吞咽困难、钡餐呈鸟嘴样狭窄→行食管下段贲门肌层切开 Heller 术治疗→在贲门失弛缓症术后可因 LES 破坏发生胃食管反流病





2.食管清除作用降低：食管蠕动能力下降（如**食管裂孔疝**）、**干燥综合征** 口干(唾液减少)→不能冲洗/稀释反流物

既会影响抗反流屏障,又会使食管清除作用降低

3.食管黏膜屏障功能降低：长期饮酒、吸烟、刺激性食物或药物（NSAIDs）等

三、由反流物引起的临床表现

1.食管和食管外症状

（1）**食管**症状

①最常见典型症状：**反流**、**烧心**（胸骨后剑突下烧灼感）本质是烧食管,内脏痛定位不准确

②因反流物刺激食管痉挛引起：**胸痛**（多为刺痛）、**吞咽困难**（多为间歇性）、**胸骨后异物感**

（2）**食管外**症状

①牙蚀症 酸雾造成牙齿的侵蚀溶解

②咽喉炎、癔球症（患者感到咽部不适，有异物感、堵塞感，但又没有真正的吞咽困难）

③声嘶 累及声带

④慢性咳嗽、非季节性哮喘、吸入性肺炎、肺间质纤维化

反流物刺激呼吸道 VS 支哮接触到了过敏原(花粉)→发作加重,有季节性

2.胃食管反流病**酷似心绞痛**

①共性：纵隔胸痛，均可向颈部、上肢、上腹部等放射 放射痛没有特异性

②区别：胃食管反流病的疼痛与体位改变有明显关系；心绞痛多为绞痛，休息或硝酸甘油有可能缓解，心电图多有异常　卧位、弯腰、腹内压升高时加重,站立、坐位时减轻

VS心绞痛:躺下休息疼痛可能缓解